

보건복지부 고시 제2026 - 169호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험법 시행령」 제19조제1항 관련 별표2 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 의한 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(보건복지부 고시 제2026-166호, 2026.7.30.)」을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 7월 30일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

I. 제2장의 "나603 철조법"란 다음에 "나605 걷기검사"란을 다음과 같이 신설한다.

항 목	제 목	세부인정사항
나605 걷기검사	나605나 점증부하 왕복 걷기검사 및 나605다 지구력 왕복 걷기검사의 급여기준	나605나 점증부하 왕복걷기검사 및 나605다 지구력 왕복걷기검사는 다음에서 정한 바에 따라 실시하고 산정한 경우에 요양급여를 인정함. - 다 음 - 가. 급여대상 1) 폐 수술(자-140, 자-141, 자-142, 자-143) 및 폐

항 목	제 목	세부인정사항
		이식술(자-810) 시행 전 환자 2) 심장재활 실시 환자 3) 호흡재활 실시 환자 나. 산정방법 1) 상기 가.에 따른 급여대상자의 초기평가를 위하여 나605나 점증부하 왕복걷기검사 및 나605다 지구력 왕복걷기검사를 동시에 실시한 경우에는 각각의 소정점수를 산정함. 2) 상기 가.에 따른 급여대상자에게 이루어진 재활치료의 효과평가를 위해 나605나 점증부하 왕복걷기검사 및 나605다 지구력 왕복걷기검사를 동시에 실시한 경우에는 주된 검사의 소정점수만 산정함.

I. 제7장의 "사130나 재활기능치료-보행치료"의 제목란 중 "사130나주2 뇌졸중 환자에서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준"을 "사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준"으로 한다.

I. 제7장의 "사130나 재활기능치료-보행치료"의 "사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준"(종전의 "사130나주2 뇌졸중 환자에서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준")의 세부인정사항란을 다음과 같이 한다.

항 목	제 목	세부인정사항
사130나 재활기능치료 -보행치료	사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하	사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련은 다음의 구분에 따른 요건을 충족하는 경우로서

항 목	제 목	세부인정사항
	뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준	「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」 별표 1에 따른 로봇보조정형용운동장치(A67080.01, 3등급)를 사용하여 실시한 경우에 한하여 요양급여를 인정함. - 다 음 - 가. 뇌졸중 환자의 경우 1) 급여대상: 다음의 요건을 모두 충족하는 환자 가) 뇌졸중(I60~I64) 환자 나) 재활치료 시작 시점의 기능적 보행지수(Functional ambulation category, FAC)가 2이하(0~5단계 기준)인 환자 2) 실시기간: 발병 후 6개월까지 나. 18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자의 경우 1) 급여대상: 재활치료 시작 시점의 대운동기능분류단계(Gross Motor Functional Classification System, GMFCS) 2~4단계 수준의 보행 기능 개선이 필요한 환자 2) 실시기간 및 횟수 가) 입원진료 시: 입원기간(입원한 날부터 퇴원한 날까지) 나) 외래진료 시 (1) 12세 이하: 주 3회 (2) 13세 이상: 주 2회

I. 제7장의 "사45 심장재활"의 "사45 심장재활 급여기준"의 세부인정사항란의 2. 라. 중 "6분 걷기검사를 한 경우 '나723 경피적 혈액산

소포화도측정[1일당] 소정점수"를 "나605 걷기검사를 한 경우 해당 걷기검사의 소정점수"로 한다.

I. 제9장의 "자651-2 경피적 좌심방이 폐색술"란 다음에 "자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술"란을 다음과 같이 신설한다.

항 목	제 목	세부인정사항
자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술	자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술의 급여기준	자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 (Percutaneous Transcatheter Mitral Valve Repair with clip)은 뉴욕심장협회 기능 등급(NYHA Class) II 이상의 증상이 있는 중증(MR 등급 3+이상)의 수술 불가능 또는 수술 고위험군의 승모판 폐쇄부전증 환자를 대상으로 심장통합진료를 거쳐 시술 여부를 결정하여야 하며, 다음의 요건을 모두 충족한 경우에 요양급여를 인정함. - 다 음 - 가. 급여대상은 아래 1) ~ 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우임. 1) 일차성(퇴행성) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 심장 혈관흉부외과 전문의를 포함한 마. 1) 및 2)의 심장통합진료에 참여한 심장통합진료팀(이하 “심장통합진료팀”이라 한다) 전원이 수술 불가능하다고 판단한 환자 2) 이차성(기능성) 심실성(VSMR, Ventricular Secondary Mitral Regurgitation) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 3개월 이상의 약물치료에도 증상이 지속되어, 심장통합진료팀 전원이 수술 불가능 또는 수술 고위험군으로 판단한 환자 3) 상기 가. 1) ~ 2) 이외의 경우에는 「선별급여

항 목	제 목	세부인정사항
		지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 적용함. 가) 일차성(퇴행성) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 STS score 8% 이상 수술 고위험군으로 판단한 환자는 본인부담률을 50%로 적용함. 나) 이차성(기능성) 심방성(ASMR, Atrial Secondary Mitral Regurgitation) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 3개월 이상의 약물치료에도 증상이 지속되어, 심장통합진료팀 전원이 수술 불가능 또는 수술 고위험군으로 판단한 환자는 본인부담률을 80%로 적용함. 4) 상기 가. 3)의 경우에는 동 행위에 사용되는 치료재료(「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」의 중분류명 “클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술용 DELIVERY SYSTEM”, “클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술용 GUIDE CATHETER”)도 해당 행위의 본인부담률을 적용함. 나. 급여횟수는 최초 시행 시 1회 인정하며, 1회를 초과하여 시행하는 경우에는 비급여 대상임. 다. 금기증은 아래와 같으며 요양급여를 인정하지 아니함. 1) 기대 여명이 1년 이하인 경우 2) 동반질환으로 인하여 삶의 질 향상을 기대하기 어려운 경우 3) 활동성 심내막염이 있는 경우 4) 류마티스성 승모판막 질환이 있는 경우 5) 심장·하대정맥(IVC) 또는 대퇴정맥에 혈전이 있는 경우 6) 승모판 폐쇄부전증 이외에 환자의 증상에 주요한 영

항 목	제 목	세부인정사항
		항을 미칠 수 있는 다른 판막질환(해당 질환이 수술로만 치료할 수 있는 경우에 한한다)이 있는 경우 7) 클립의 성분 또는 조영제에 과민반응이 발생하는 경우 8) 항응고제 또는 항혈소판제에 과민반응이 발생하는 경우 라. 시설·장비·인력 및 실적 기준 1) 심장 수술이 가능한 시설과 체외순환막형산화용 기기(Extra Corporeal Membrane Oxygenator, ECMO) 또는 심장수술용체외순환기(심폐기)를 구비하여야 함. 2) 인력은 가), 나)를 모두 충족하여야 하며 당해 요양기관에 상근하여야 함. 가) 분과전문의 자격 취득 후 5년 이상의 순환기 내과 진료 경험이 있는 순환기내과 분과전문의 2인 이상 나) 전문의 자격 취득 후 5년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상 또는 전문의 자격 취득 후 10년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 1인 이상 3) 연간 실적이 다음의 기준을 모두 충족해야 함. 가) 판막성형술-승모판과 인공판막치환술-승모판의 각 시행 실적을 합산한 건수가 20건 이상 나) 경피적 관상동맥 중재적 시술의 시행 실적이 100건 이상 4) 동 시술을 실시하고자 하는 요양기관은 별지 제41호 서식의 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 실시기관 신고서에 1)부터 3)까지의 기준을 모두 충족한 사실을 입증하기 위한 서류를 첨부하여

항 목	제 목	세부인정사항												
		다음의 표에서 정하는 바에 따라 매년 건강보험심사평가원장에게 제출해야 함. 이 경우 변경사항이 발생할 경우에는 지체 없이 변경 신고를 해야 함. <table><tr><th>신고 주기</th><th>신고 기간</th><th>3)에 따른 연간 실적 인정 기간</th><th>적용 기간 (동 시술 가능)</th></tr><tr><td>상반기</td><td>6월 1일부터 6월 14일까지</td><td>지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31일까지</td><td>당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지</td></tr><tr><td>하반기</td><td>12월 1일부터 12월 14일까지</td><td>지난 연도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지</td><td>다음 연도 1월 1일부터 다음 연도 12월 31일까지</td></tr></table> 5) 시술이 진행되는 동안 심장혈관흉부외과 전문의, 마취통증의학과 전문의, 체외순환 전문인력이 요양기관 내에 대기하여야 하며 이에 대하여 진료기록부에 기록·관리하여야 함. 마. 심장통합진료는 아래와 같이 실시하되 관련 분야 전문의들이 내과적 시술 및 외과적 수술의 위험과 편익을 종합적으로 고려하여 환자의 치료 방침을 결정하여야 함. 1) 심장통합진료팀은 다음의 전문의를 반드시 포함하여 구성해야함. 가) 순환기내과 분과전문의 2인 이상. 이 경우 순환기내과 분과전문의에는 한국심초음파학회에서 인정하는 심초음파 인증의 1인이 포함되어야 함. 나) 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상(단, 전문의 자격 취득 후 10년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 경우에는 1인 이상) 2) 심장통합진료팀은 마. 1)의 전문의 이외에 마취통증의학과 전문의, 영상의학과 전문의 등 필요한 인력을 포함하여 구성할 수 있음. 3) 심장통합진료팀은 심장통합진료에 대면으로 참여	신고 주기	신고 기간	3)에 따른 연간 실적 인정 기간	적용 기간 (동 시술 가능)	상반기	6월 1일부터 6월 14일까지	지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31일까지	당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지	하반기	12월 1일부터 12월 14일까지	지난 연도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지	다음 연도 1월 1일부터 다음 연도 12월 31일까지
신고 주기	신고 기간	3)에 따른 연간 실적 인정 기간	적용 기간 (동 시술 가능)											
상반기	6월 1일부터 6월 14일까지	지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31일까지	당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지											
하반기	12월 1일부터 12월 14일까지	지난 연도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지	다음 연도 1월 1일부터 다음 연도 12월 31일까지											

항 목	제 목	세부인정사항
		하되, 부득이한 경우에는 화상으로 참여할 수 있음. 다만, 마. 2)의 전문의는 별도의 협진으로 대면 및 화상 참여를 대신할 수 있음. 4) 심장통합진료팀 전원이 동 시술의 시행에 동의한 경우 동 시술을 시행할 수 있음. 5) 심장통합진료팀은 심장통합진료팀 전원이 동 시술의 시행에 동의하지 않은 경우 재논의를 거쳐 합의된 치료방침을 결정해야함. 이 경우 재논의에는 환자 담당 전문의(주치의)와 시술 담당 전문의가 반드시 참여해야 함. 6) 순환기내과 전문의와 심장혈관흉부외과 전문의는 마. 1)의 심장통합진료 이전 또는 마. 5)의 재논의 이전에 환자 또는 보호자에게 각 치료법의 위험과 편익을 충분히 설명하여야 하며, 재논의에 참여한 환자 담당 전문의는 의료진의 최종 결정사항을 환자 또는 보호자에게 충분히 설명하여야 함. 7) 경흉부 초음파, 경식도 초음파, 심장 관련 CT 촬영 결과 등 필수적인 검사결과를 구비한 후에 심장통합진료를 실시하여야 하며, 별지 제42호 서식의 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 심장통합진료 기록지에 심장통합진료 시간 및 장소, 참여 전문의 성명 및 서명, 치료방침 및 결정사유 등을 기재하여 요양급여비용 청구 시 서식을 첨부하여야 함. 바. 기타 1) 실시기관은 치료효과성 등의 판단을 위해 시술 결정 사유, 시술 전후 환자 상태, 합병증 발생 유무 등에 대한 임상 자료를 별지 제43호 서식의 「시술 전중후」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 임상자료 관리 항목 및 제44호 서식의

항 목	제 목	세부인정사항
		「추적관찰」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 임상자료 관리 항목을 통해 관리하여야 함. 2) 치료효과성 등 급여 적정성에 대한 재평가에 필요한 세부사항은 별도로 정함.

IV. 제2장의 “나723 경피적 혈액산소포화도측정”란을 삭제한다.

별지 제41호 서식부터 별지 제44호 서식까지를 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술의 시설·장비·인력 및 실적 기준 신고에 관한 경과조치) I. 제9장의 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행 이후에 건강보험심사평가원장이 정하여 공고하는 바에 따라 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술의 시설·장비·인력 및 실적 기준 등을 신고한 요양기관은 I. 제9장의 “자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술”의 “자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술의 급여 기준”의 세부인정사항란의 라. 4)의 개정규정에 따라 상반기 신고주기에 신고한 것으로 본다.

**클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 실시기관 신고서
(신규·갱신·변경)**

요양 기관	명칭		기호	
	주소		전화번호	

「자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 급여기준」(보건복지부
고시 제2026-00호, 2026.0.00.)에 따라 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판
재건술 실시기관으로 (변경)신고합니다.

년 월 일

대 표 자: (서명 또는 인)

담당자 성명:

전화번호:

이메일:

건강보험심사평가원장 귀하

※ 구비서류

1. 장비 관련 자료
2. 상근 인력 관련 자료
3. 연간 실적 관련 자료

(구비 서류)

1. 장비

번호	장비 명칭	식약처 허가번호	모델명
1	체외순환막형산화용기기 (ECMO)		
2	심장수술용체외순환기 (심폐기)		

2. 상근 인력

- 분과전문의 자격 취득 후 5년 이상의 순환기내과 진료 경험이 있는
순환기내과 분과전문의 2인 이상

번호	성명	순환기내과 분과전문의			입사일
		자격번호	자격취득일	인정기간	
1					
2					

※ 순환기내과 분과전문의 인정기간은 최근 인정기간을 기재

- 전문의 자격 취득 후 5년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관
흉부외과 전문의 2인 이상 또는 10년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는
심장혈관흉부외과 전문의 1인 이상

번호	성명	전문의 자격번호	자격취득일	입사일
1				
2				

3. 연간 실적

항목	실적(건수)		분류번호
수술 관련 실적	계:		자178나 판막성형술-승모판
			자179나 인공판막치환술-승모판
경피적 관상동맥 중재적 시술(PCI)	계:		자655가 경피적 관상동맥 확장술-단일혈관
			자656가 경피적 관상동맥 스텐트 삽입술-단일혈관
			자656가 경피적 관상동맥 스텐트 삽입술-단일혈관 주: 경피적 관상동맥 확장술(PTCA) 및 경피적 관상동맥 주 상반절제술과 동시에 시술한 경우
			자657가 경피적 관상동맥 주상반절제술-단일혈관

※ 연간 실적은 해당 요양기관의 상근자가 실시한 경우에 한함

※ 상반기 신고(매년 6월): 지난 연도 1월 1일부터 12월 31일까지의 실적을 기재

하반기 신고(매년 12월): 지난 연도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지의 실적을 기재

4. 임상자료 관련 연간 시술 실적(건수)

(단위: 건)

구분	실적(건수)	보험자구분				
		건강보험	의료급여	산업재해	자동차보험	기타
일차성 수술 불가능군 (급여대상)	계:					
이차성(심실성)군 (급여대상)	계:					
일차성 수술 고위험군 (본인부담률 50%)	계:					
이차성(심방성)군 (본인부담률 80%)	계:					
기타(비급여 등)	계:					

※ 연간 실적은 해당 요양기관의 상근자가 실시한 경우에 한함

※ 상반기 신고(매년 6월): 지난 연도 1월 1일부터 12월 31일까지의 실적을 기재

하반기 신고(매년 12월): 지난 연도 7월 1일부터 당해 연도 6월 30일까지의 실적을 기재

※ 기타(비급여 등)의 경우 실시 조건 적합 여부를 확인할 수 있는 자료 등 관련 서류의 제출
요청 가능

클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 심장통합진료 기록지

요양기관명 (요양기호)		일시 · 장소	(일시) 년 월 일, 00:00~00:00 (장소)
환자명		성별	나이 세

1. 적응증

가. 증상

NYHA 기능 분류 (시술 전 안정 시)	☐ 1. Class I ☐ 2. Class II ☐ 3. Class III ☐ 4. Class IV
MR(역류) 등급	☐ 1. 0 ☐ 2. 1+ ☐ 3. 2+ ☐ 4. 3+ ☐ 5. 4+

나. Valve Hemodynamics

시술 전 심초음파 검사 일자	_____ 년 ____ 월 ____ 일		
좌심실 박출률(LVEF)	_____ %		
좌심실 수축기말 직경(LVESD)	_____ mm	좌심실 이완기말 직경(LVESD)	_____ /mm
유효 역류 면적(EROA)	_____ cm ²	역류 혈액량	_____ ml
승모판 역류 형태			
☐ 1. 일차성(퇴행성) ☐ 2. 이차성(심실성) ☐ 3. 이차성(심방성)			

다. 수술 위험도

STS score	_____ %
☐ 1. 수술 불가능군 ☐ 2. 수술 고위험군	

2. 금기증

기대 여명 1년 이하	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
동반질환으로 인하여 삶의 질 향상을 기대하기 어려운 경우	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네 (동반질환 : _____)
활동성 심내막염	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
류마티스성 승모판막 질환	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
심장 · 하대정맥 · 대퇴정맥 내 혈전	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
환자의 증상에 주요한 영향을 미치는 수술로만 치료 가능한 다른 판막질환 존재	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
클립성분, 조영제에 과민반응	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네
항응고제, 항혈소판제에 과민반응	☐ 1. 아니오 ☐ 2. 네

3. 심장통합진료 참여 전문의 의견 (인원수에 따라 양식 추가)

▪ 순환기내과 전문의1 (심초음파 인증의)

의견	시술 동의 여부	☐ 네	☐ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 순환기내과 전문의2

의견	시술 동의 여부	☐ 네	☐ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 심장혈관흉부외과 전문의1

인력 정보	전문의 자격 취득 후 10년 이상 심혈관 수술 경험 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	시술 동의 여부	☐ 네	☐ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 심장혈관흉부외과 전문의2

의견	시술 동의 여부	☐ 네	☐ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 마취통증의학과 전문의 (필요 시 작성)

의견	시술 동의 여부	○ 네	○ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 영상의학과 전문의 (필요 시 작성)

의견	시술 동의 여부	○ 네	○ 아니오
	(상세 의견)		
이름/서명 _____ / _____			

▪ 최종 치료방침 및 결정사유

치료방침 : ☐ 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 ☐ 수술적 판막성형술 등

결정사유 :

--

▪ 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 시술 계획 (치료방침이 “해당 행위” 인 경우만 작성)

Valve Type	
Valve Size	
Access	○1. 대퇴정맥

4. 재논의 참여 전문의 의견 (재논의 시만 작성)

일시	년 월 일, 00:00~00:00
장소	

▪ 순환기내과 전문의1 (심초음파 인증의)

인력 정보	환자 담당 전문의(주치의) 여부	☐ 네	☐ 아니오
	시술 담당 전문의 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	(상세 의견)		
	이름/서명 _____ / _____		

▪ 순환기내과 전문의2

인력 정보	환자 담당 전문의(주치의) 여부	☐ 네	☐ 아니오
	시술 담당 전문의 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	(상세 의견)		
	이름/서명 _____ / _____		

▪ 심장혈관흉부외과 전문의1

인력 정보	전문의 자격 취득 후 10년 이상 심혈관 수술 경험 여부	☐ 네	☐ 아니오
	환자 담당 전문의(주치의) 여부	☐ 네	☐ 아니오
	시술 담당 전문의 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	(상세 의견)		
	이름/서명 _____ / _____		

■ 심장혈관흉부외과 전문의2

인력 정보	환자 담당 전문의(주치의) 여부	☐ 네	☐ 아니오
	시술 담당 전문의 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	(상세 의견) 이름/서명 _____ / _____		

■ 환자 담당 전문의(주치의) (필요 시 작성)

인력 정보	시술 담당 전문의 여부	☐ 네	☐ 아니오
의견	(상세 의견) 이름/서명 _____ / _____		

■ 시술 담당 전문의 (필요 시 작성)

의견	(상세 의견) 이름/서명 _____ / _____
----	--

■ 마취통증의학과 전문의 (필요 시 작성)

의견	(상세 의견) 이름/서명 _____ / _____
----	--

▪ 영상학과 전문의 (필요 시 작성)

의견	(상세 의견)
	이름/서명 _____ / _____

▪ 최종 치료방침 및 결정사유

치료방침 : ☐ 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 ☐ 수술적 판막성형술 등

결정사유 :

--

「시술 전·중·후」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 임상자료 관리 항목

구분	제출 목록
1.환자 기본 정보	1. 생년월일 _____ (YYYY/MM/DD)
	2. 성별 ☐ 남 ☐ 여
	3. 신장(Height) (_____ cm)
	4. 체중(Weight) (_____ kg)
	5. 체질량지수(Body Mass Index) (_____ kg/m ²)
	6. 시술일 _____ (YYYY/MM/DD)
2. 병력 및 위험인자	1. NYHA Functional Class (NYHA 등급, 시술 전) ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV
	2. 심부전 입원(시술일로부터 1년 이내) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름 - 예 인 경우, 입원 횟수 ()회
	3. 부정맥 유무 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	4. 심방세동 유무 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름 - 예 인 경우, ☐ Paroxysmal(발작성) ☐ Persistent(지속적) ☐ Permanent(영구적)
	5. 심방조동 유무 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	6. 이전 심근경색(Prior MI) 유무 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	7. 이전 PCI 시행 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	8. 이전 CABG 시행 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	9. 이전 판막 수술/ 시술 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름 - 예 인 경우, ☐ MV Repair ☐ TEER ☐ MV Replace ☐ TAVR ☐ SAVR ☐ Surgical AV Repair ☐ TV Surgery ☐ 기타 ()
	9.1 이전 승모판 성형술 여부 (Prior Mitral Annuloplasty Ring) ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	10. 인공심박동기 삽입 여부 (Permanent Pacemaker) ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	11. 심장재동기화 장비(CRT/CRT-D) 삽입 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	12. 이식형 제세동기(ICD) 삽입 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	13. 이전 뇌졸중(CVA), 일과성 뇌허혈발작(TIA)여부 ☐ CVA ☐ TIA ☐ 아니오 ☐ 모름
	14. 고혈압(Hypertension) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	15. 이상지질혈증(Dyslipidemia) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	16. 당뇨(Diabetes Mellitus) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름 예 인 경우, ☐ Type I ☐ Type II
	17. 신기능 장애(Renal Dysfunction) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
	17-1. 투석 여부 (Dialysis) ☐ 예 ☐ 아니오
	18. 만성 폐질환(COPD) 여부 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름

	(3쪽 중 2쪽)																												
	19. 말초혈관질환(PAD) 여부 ○ 예 ○ 아니오 ○ 모름																												
	20. 악성종양(Cancer) 여부 ○ 예 ○ 아니오 ○ 모름																												
	21. 현재 흡연 여부 ○ 예 ○ 아니오 ○ 모름																												
3. 수술 위험도	1. MV Replacement(승모판막 치환술)시 수술 위험도(STS SCORE) ()% ○ Not Assessed 2. MV Repair(승모판 성형술)시 수술 위험도(STS SCORE) ()% ○ Not Assessed 3. 수술 불가 판정 여부 ○ 예 ○ 아니오 (사유:) 4. 수술 고위험 판정 여부 ○ 예 ○ 아니오 (사유:)																												
4. 시술 전 심초음파	1.TTE(시술 전 심초음파) 시행 일자 ____/____/____ (YYYY/MM/DD) 2. 승모판 역류 원인(MR Etiology) ○ 일차성(퇴행성) ○ 이차성(기능성) ○ Mixed 2-1. 일차성(퇴행성)인 경우, Prolapse Location ○ Central ○ Non-Central 2-2. 이차성(기능성)인 경우, ○ 심실성(Ventricular FMR) ○ 심방성(Atrial FMR) 3. 승모판 역류 중증도(MR Severity) (TTE) ○0 (None) ○1+ ○2+ ○3+ ○4+ 4. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area) 2D ____.(cm²) (○ Not Measured) 5. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area) 3D ____.(cm²) (○ Not Measured) 6. 승모판 평균 혈류 압력차(MV Mean Gradient ____.(mmHg) (○ Not Measured) 7. 좌심실박출률(LVEF) ____ (%) (○ Not Measured) 8. 삼첨판 역류 중증도(TR Severity) ○None ○Mild ○Moderate ○Severe																												
5. 시술 정보	A. 시술 일반 정보 1. 시술일: ____/____/____ (YYYY/MM/DD) 2. 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술(TEER) Device System(장비 명칭) ○ Mitraclip ○ PASCAL ○ 기타 3. 삽입 클립 개수 ____ 개 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Clip</th><th style="width: 15%;">Device</th><th style="width: 15%;">Type/Size</th><th style="width: 15%;">Lot Number (제조번호)</th><th style="width: 15%;">Implant 결과</th><th style="width: 15%;">SLDA (Single Leaflet Device Attachment)</th><th style="width: 20%;">Grasping Location</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clip 1</td><td>○ MC ○ PASCAL ○ 기타</td><td>NT / XT / NTW /XTW</td><td>_____</td><td>Implanted / Not</td><td>Yes / No</td><td>A1P1 / A2P2 / A3P3</td></tr> <tr> <td>Clip 2</td><td>○ MC ○ PASCAL ○ 기타</td><td>NT / XT / NTW /XTW</td><td>_____</td><td>Implanted / Not</td><td>Yes / No</td><td>A1P1 / A2P2 / A3P3</td></tr> <tr> <td>Clip 3</td><td>○ MC ○ PASCAL ○ 기타</td><td>NT / XT / NTW /XTW</td><td>_____</td><td>Implanted / Not</td><td>Yes / No</td><td>A1P1 / A2P2 / A3P3</td></tr> </tbody> </table>	Clip	Device	Type/Size	Lot Number (제조번호)	Implant 결과	SLDA (Single Leaflet Device Attachment)	Grasping Location	Clip 1	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3	Clip 2	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3	Clip 3	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3
Clip	Device	Type/Size	Lot Number (제조번호)	Implant 결과	SLDA (Single Leaflet Device Attachment)	Grasping Location																							
Clip 1	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3																							
Clip 2	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3																							
Clip 3	○ MC ○ PASCAL ○ 기타	NT / XT / NTW /XTW	_____	Implanted / Not	Yes / No	A1P1 / A2P2 / A3P3																							
	B. 시술 결과 (Procedural Outcome) 1. 시술 후 승모판 역류 등급(Post-Implant MR Grade (TEE)) ○ 0 ○ 1+ ○ 2+ ○ 3+ ○ 4+ 2. 시술 후 승모판 압력차(Post-Implant MV Gradient) _____(mmHg) ○ Not Measured 3. 시술 후 승모판막 면적(Post-Implant MVA) ____.(cm²) ○ Not Measured																												

	4. 시술 관련 합병증(Procedure-related complication) ☐ 예 ☐ 아니오 4-1. 시술 관련 합병증 내용----- 예 인 경우, 구체적 합병증 ()
	5. 퇴원일 ____/____/____ (YYYY/MM/DD)
6 시술 후 심초음파	1. TTE(시술 후 심초음파) 시행 일자 ____/____/____ (YYYY/MM/DD)
	2. 승모판 역류 중증도(MR Severity) (TTE) ☐ 0 (None) ☐ 1+ ☐ 2+ ☐ 3+ ☐ 4+
	3. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area) 2D ____CM ² (☐ Not Measured)
	4. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area) 3D ____ (cm ²) (☐ Not Measured)
	5. 승모판 평균 혈류 압력차(MV Mean Gradient: ____ (mmHg) (☐ Not Measured)
	6. 좌심실박출률(LVEF): ____ (%) (☐ Not Measured)
	7. 삼첨판 역류 중증도(TR Severity) ☐ None ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Severe
7. 기타 사항	1. 첨부 (클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 진료기록지 등 관련 파일이 있는 경우 첨부)

- 주1. '시술 결과, 시술 후 심초음파' 는 시술 후 10일 이내 퇴원한 경우 퇴원 시 작성, 시술 후 10일을 초과하여 퇴원한 경우 10일 시점을 기준으로 작성
2. 제출된 자료를 증빙할 수 있는 진료기록지, 시술기록지 별도 제출
3. 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술과 인과관계 여부, 시행처치에 대한 자료 별도 제출

「추적·관찰」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 임상자료 관리 항목	
구분	제출 목록
1. 환자 기본 정보	1. 생년월일 _____/____/____ (YYYY/MM/DD)
	2. 성별 ☐ 남 ☐ 여
	3. 신장(Height) (_____ cm)
	4. 체중(Weight) (_____ kg)
	5. 체질량지수(Body Mass Index) (_____ kg/m ²)
	6. 시술일 _____/____/____ (YYYY/MM/DD)
2. 추적관찰 (Follow-up)	1. 방문일____/____/____ (YYYY/MM/DD)
	1-1. 방문 일자 구분 코드 ☐ 퇴원 시 ☐ 시술 후 30일 ☐ 시술 후 1년 ☐ 시술 후 2년 ☐ 시술 후 3년
	2. NYHA Functional Class(NYHA 등급, 추적관찰 시) ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV
	A. 심초음파(TTE)
	3. TTE(추적 관찰 심초음파) 시행일자 _____/____/____ (YYYY/MM/DD)
	4. 승모판 역류 중증도(MR Severity): ☐ 0 (None) ☐ 1+ ☐ 2+ ☐ 3+ ☐ 4+
	5. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area(cm ²) 2D ____.
	6. 승모판 면적(MVA, Mitral Valve Area(cm ²) 3D ____.
	7. 승모판 평균 혈류 압력차(MV Mean Gradient: _____(mmHg) (☐ Not Measured)
	8. 좌심실박출률(LVEF): _____ (%) (☐ Not Measured)
3. 이상사례 (Adverse Events)	9. 삼첨판 역류 중증도(TR Severity): ☐ None ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Severe
	B. 사건(Events)
	10. 새로운/악화된 이상사례(AE) 여부 ☐ Yes → 아래 이상사례(AE) Form 작성 ☐ No
	1. 이상 사례 발생 일자 _____/____/____ (YYYY/MM/DD)
	2. 이상 사례 명칭 (AE Term)_____
	3. 이상 사례 분류 (해당 선택 시 일자 기입) (YYYY/MM/DD) _____ / _____ / _____
	☐ 모든 경우 사망(All-cause Death)일자 _____ / _____ / _____
	☐ 심혈관계 사망(Cardiovascular Death)일자 _____ / _____ / _____
	☐ 승모판 재시술/수술(Mitral valve reintervention/Surgery)일자 _____ / _____ / _____
	☐ 응급/긴급 심혈관 수술(Non-elective CV Surgery)일자 _____ / _____ / _____
☐ 뇌졸중(Stroke (CVA))발생 일자 _____ / _____ / _____	
☐ 일과성 뇌허혈발작(TIA)발생 일자 _____ / _____ / _____	
☐ 심근경색(Myocardial Infarction)발생 일자 _____ / _____ / _____	
☐ 주요 출혈(Major Bleeding (BARC 3 이상))발생 일자 _____ / _____ / _____	

	(2쪽 중 2쪽)
	○ 단일 판막엽 장치(Single Leaflet Device Attachment)삽입 일자 ____ / ____ / ____
	○ 클립 색전증(Clip Embolization)발생 일자 ____ / ____ / ____
	○ 심내막염(Endocarditis)발생 일자 ____ / ____ / ____
	○ 모든 원인으로 인한 재입원(Any Hospitalization) 일자 ____ / ____ / ____
	○ 심부전 관련 입원(Heart Failure Hospitalization) 일자 ____ / ____ / ____
	○ 기기 결함(Device Deficiency) 발생 일자 ____ / ____ / ____
○ 이외 이상사례(Other AE) (specify) 발생 일자 ____ / ____ / ____	
4. 치료 결과 (Outcome) ○ 회복(무후유증) ○ 회복 중 ○ 후유증 잔존 ○ 사망	
5. 이상사례 상세 내용 (Description)	
4. 기타 사항	1. 첨부 (클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 진료기록지 등 관련 파일이 있는 경우 첨부)

- 주1. 추적관찰(퇴원, 30일, 1년, 2년, 3년) 결과 작성 시 퇴원, 30일 기록은 ±10일 이내, 1년, 2년, 3년은 ±90일 시점을 기준으로 작성
2. 이상사례(합병증 및 부작용)은 시술 중·후 모두 포함하여 작성
3. 제출된 자료를 증빙할 수 있는 진료기록지, 시술기록지 별도 제출
4. 이상사례(합병증 및 부작용) 발생항목의 경우 부작용 발생일, 심각한 이상반응 여부, 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술과 인과관계 여부, 시행처치에 대한 자료 별도 제출

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 신구조문 대비표

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
I. 행위 제2장 검사료			I. 행위 제2장 검사료			
<u><신설></u>	<u><신설></u>	<u><신설></u>	<u>나605</u> <u>걷기검사</u>	<u>나605나</u> <u>점증부하</u> <u>왕복</u> <u>걷기검사 및</u> <u>나605다</u> <u>지구력 왕복</u> <u>걷기검사의</u> <u>급여기준</u>	<u>나605나 점증부하 왕복걷기검사 및</u> <u>나605다 지구력 왕복걷기검사는</u> <u>다음에서 정한 바에 따라 실시하</u> <u>고 산정한 경우에 요양급여를 인</u> <u>정함.</u> <u>- 다 음 -</u> <u>가. 급여대상</u> <u>1) 폐 수술(자-140, 자-141, 자-142,</u> <u>자-143) 및 폐이식술(자-810) 시</u> <u>행 전 환자</u> <u>2) 심장재활 실시 환자</u> <u>3) 호흡재활 실시 환자</u>	(제개정 사유) 신의료기술 등재 관련 고시 신설

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					나. 산정방법 1) 상기 가.에 따른 급여대상자의 초기평가를 위하여 나605나 점증부하 왕복걷기검사 및 나605다 지구력 왕복걷기검사를 동시에 실시한 경우에는 각각의 소정점수를 산정함. 2) 상기 가.에 따른 급여대상자에게 이루어진 재활치료의 효과평가를 위해 나605나 점증부하 왕복걷기검사 및 나605다 지구력 왕복걷기검사를 동시에 실시한 경우에는 주된 검사의 소정점수만 산정함.	
I. 행위			I. 행위			
제7장 이학요법료			제7장 이학요법료			
사130나 재활기능치료-보행치료	사130나주2 뇌졸중 <신설>	사130나주2 뇌졸중 <신설> 환자에 선 로봇을 사용한 보행훈련은 다음의 경우 요양급여를 인정함.	사130나 재활기능치료-보행치료	사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하	사130나주2 뇌졸중 및 18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련은 다음	(제·개정 사유) 로봇을 사용한 보행훈련

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
	환자에서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준	- 다 음 - 가. 급여대상: 1)~2) 조건을 모두 충족하는 경우 1) 뇌졸중(I60~I64) 환자 2) 재활치료 시작 시점의 기능적 보행지수(Functional ambulation category, FAC)가 2이하(0~5단계 기준)인 환자		뇌성마비 등 중추신경계 질환 환자에 있어서 로봇을 사용한 보행훈련의 급여기준 - 다 음 - 가. 뇌졸중 환자의 경우 1) 급여대상: 다음의 조건을 모두 충족하는 환자 가) 뇌졸중(I60~I64) 환자 나) 재활치료 시작 시점의 기능적 보행지수(Functional ambulation category, FAC)가 2이하(0~5단계 기준)인 환자 2) 실시기간: 발병 후 6개월까지	의 구분에 따른 요건을 충족하는 경우로서 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」 별표 1에 따른 로봇 보조정형용운동장치(A67080.01, 3등급)를 사용하여 실시한 경우에 한하여 요양급여를 인정함. - 다 음 -	대상 확대

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		<u>나. 실시기간: 발병 후 6개월까지</u> <u><신설></u> <u>다. 장비기준 식품의약품안전처 「의료</u>			<u>나. 18세 이하 뇌성마비 등 중추 신경계 질환 환자의 경우</u> <u>1) 급여대상: 재활치료 시작 시점의 대운동기능분류단계(Gross Motor Functional Classification System, GMFCS) 2~4단계 수준의 보행 기능 개선이 필요한 환자</u> <u>2) 실시기간 및 횟수</u> <u>가) 입원진료 시: 입원기간(입원한 날부터 퇴원한 날까지)</u> <u>나) 외래진료 시</u> <u>(1) 12세 이하: 주 3회</u> <u>(2) 13세 이상: 주 2회</u> <u><삭제></u>	

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 따른 로봇보조 정형용운동장치(A67080.01, 3등급)				
사45 심장재활	사45 심장재활 급여기준	1. <생략> 가. ~ 다. <생략> 2. <생략> 가. ~ 다. <생략> 라. 운동능력이 저하되어 심장재 활평가(심폐운동 부하검사)를 시행하기 어려운 환자에 한 해서 <u>6분 걷기검사를 한 경우</u> <u>‘나723 경피적 혈액산소포화</u> <u>도측정[1일당]’</u> 소정점수를 산정하고, 심장재활치료를 제 7장 이학요법료 제1절에 분 류된 단순운동치료, 제2절에 분류된 운동치료와 동시에	사45 심장재활	사45 심장재활 급여기준	1. <현행과 같음> 가. ~ 다. <현행과 같음> 2. <현행과 같음> 가. ~ 다. <현행과 같음> 라. 운동능력이 저하되어 심장재 활평가(심폐운동 부하검사)를 시행하기 어려운 환자에 한 해서 <u>나605 걷기검사를 한</u> <u>경우 해당 걷기검사의</u> 소정 점수를 산정하고, 심장재활치 료를 제7장 이학요법료 제1 절에 분류된 단순운동치료, 제2절에 분류된 운동치료와 동시에 실시하는 경우 주된	(제·개정 사유) 신의료기술 등재 관련 고시 신설

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		실시하는 경우 주된 항목의 소정점수만 산정함. 마. <생략>			항목의 소정점수만 산정함. 마. <현행과 같음>	
I. 행위 제9장 처치 및 수술료 등			I. 행위 제9장 처치 및 수술료 등			
<신설>	<신설>	<신설>	자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술	자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술의 급여기준	자653-1 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술(Percutaneous Transcatheter Mitral Valve Repair with clip)은 뉴욕 심장협회 기능 등급(NYHA Class) II 이상의 증상이 있는 중증(MR 등급 3+ 이상)의 수술 불가능 또는 수술 고위험 군의 승모판 폐쇄부전증 환자를 대상으로 심장통합진료를 거쳐 시술 여부를 결정 하여야 하며, 다음의 요건을 모두 충족 한 경우에 요양급여를 인정함. - 다 음 -	(제·개정 사유) 신의료기술 등재 관련 고시 신설

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					가. 급여대상은 아래 1) ~ 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우임. 1) <u>일차성(퇴행성) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 심장혈관흉부외과 전문의를 포함한 바. 1) 및 2)의 심장통합진료에 참여한 심장통합진료팀(이하 “심장통합진료팀”이라 한다) 전원이 수술 불가능하다고 판단한 환자</u> 2) <u>이차성(기능성) 심실성(VSMR, Ventricular Secondary Mitral Regurgitation) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 3개월 이상의 약물 치료에도 증상이 지속되어, 심장통합진료팀 전원이 수술 불가능 또는 수술 고위험군으로 판단한 환자</u> 3) <u>상기 가. 1) ~ 2) 이외의 경우에는 「선별급여 지정 및 실</u>	

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 적용함. 가) 일차성(퇴행성) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 STS score 8% 이상 수술 고위험군으로 판단한 환자는 본인부담률을 50%로 적용함. 나) 이차성(기능성) 심방성(ASMR, Atrial Secondary Mitral Regurgitation) 승모판 폐쇄부전증 환자 중 3개월 이상의 약물치료에도 증상이 지속되어, 심장통합진료팀 전원이 수술 불가능 또는 수술 고위험군으로 판단한 환자는 본인부담률을 80%로 적용함. 4) 상기 가. 3)의 경우에는 동 행위에 사용되는 치료재료(「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」의 중분류명 “클립	

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					<u>을 사용한 경피적 경도관 승모관 재건술용 DELIVERY SYSTEM, “클립을 사용한 경피적 경도관 승모관 재건술용 GUIDE CATHETER”)도 해당 행위의 본인부담률을 적용함.</u> <u>나. 급여횟수는 최초 시행 시 1회 인정하며, 1회를 초과하여 시행하는 경우에는 비급여 대상임.</u> <u>다. 급기증은 아래와 같으며 요양급여를 인정하지 아니함.</u> <u>1) 기대 여명이 1년 이하인 경우</u> <u>2) 동반질환으로 인하여 삶의 질 향상을 기대하기 어려운 경우</u> <u>3) 활동성 심내막염이 있는 경우</u> <u>4) 류마티스성 승모판막 질환이 있는 경우</u> <u>5) 심장·하대정맥(IVC) 또는 대퇴정맥 혈전이 있는 경우</u>	

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					6) <u>승모판 폐쇄부전증 이외에 환자의 증상에 주요한 영향을 미칠 수 있는 다른 판막질환(해당 질환이 수술로만 치료할 수 있는 경우에 한한다)이 있는 경우</u> 7) <u>클립의 성분 또는 조영제에 과민반응이 발생하는 경우</u> 8) <u>항응고제 또는 항혈소판제에 과민반응이 발생하는 경우</u> 라. <u>시설·장비·인력 및 실적 기준</u> 1) <u>심장 수술이 가능한 시설과 체외순환막형산화용기기(Extra Corporeal Membrane Oxygenator, ECMO) 또는 심장수술용체외순환기(심폐기)를 구비하여야 함.</u> 2) <u>인력은 가), 나)를 모두 충족하여야 하며 당해 요양기관에 상근하여야 함.</u>	

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					가) <u>분과전문의 자격 취득 후 5년 이상의 순환기내과 진료 경험이 있는 순환기내과 분과전문의 2인 이상</u> 나) <u>전문의 자격 취득 후 5년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상 또는 전문의 자격 취득 후 10년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 1인 이상</u> 3) <u>연간 실적이 다음의 기준을 모두 충족해야 함.</u> 가) <u>판막성형술-승모판과 인공판막치환술-승모판의 각 시행 실적을 합산한 건수가 20건 이상</u> 나) <u>경피적 관상동맥 중재적 시술의 시행 실적이 100건 이상</u>	

현행			개정			비고							
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항								
					4) 동 시술을 실시하고자 하는 요양기관은 별지 제41호 서식의 클립을 사용한 경피적 경도관 송모판 재건술 실시기관 신고서에 1)부터 3)까지의 기준을 모두 충족한 사실을 입증하기 위한 서류를 첨부하여 다음의 표에서 정하는 바에 따라 매년 건강보험심사평가원장에게 제출해야 함. 이 경우 변경사항이 발생할 경우에는 지체 없이 변경 신고를 해야 함. <table><tr><th>신고 주기</th><th>신고 기간</th><th>3)에 따른 연간 실적 인정 기간</th><th>적용 기간 (동 시술 가능)</th></tr><tr><td>상반기</td><td>6월 1일부터 6월 14일까지</td><td>지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31</td><td>당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지</td></tr></table>	신고 주기	신고 기간	3)에 따른 연간 실적 인정 기간	적용 기간 (동 시술 가능)	상반기	6월 1일부터 6월 14일까지	지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31	당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지
신고 주기	신고 기간	3)에 따른 연간 실적 인정 기간	적용 기간 (동 시술 가능)										
상반기	6월 1일부터 6월 14일까지	지난 연도 1월 1일부터 지난 연도 12월 31	당해 연도 7월 1일부터 다음 연도 6월 30일까지										

현행			개정			비고																								
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항																									
					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>일까지</td><td>지</td></tr><tr><td rowspan="4">하 반 기</td><td>12월 1</td><td>지난 연</td><td>다음 연도</td></tr><tr><td>일 부 터</td><td>도 7월 1</td><td>1월 1일부</td></tr><tr><td>12월 14</td><td>일 부 터</td><td>터 다음 연</td></tr><tr><td>일까지</td><td>당해 연</td><td>도 12월</td></tr><tr><td></td><td></td><td>도 6월</td><td>31일까지</td></tr><tr><td></td><td></td><td>30일까지</td><td></td></tr></table> 5) <u>시술이 진행되는 동안 심장혈관흉부외과 전문의, 마취통증의학과 전문의, 체외순환 전문인력이 요양기관 내에 대기하여야 하며 이에 대하여 진료기록부에 기록·관리하여야 함.</u> 마. <u>심장통합진료는 아래와 같이 실시하되 관련 분야 전문의들이 내과적 시술 및 외과적수술의 위험과 편익을 종합적으로 고려하여 환자의 치료방침을 결정하여야 함.</u> 1) <u>심장통합진료팀은 다음의</u>			일까지	지	하 반 기	12월 1	지난 연	다음 연도	일 부 터	도 7월 1	1월 1일부	12월 14	일 부 터	터 다음 연	일까지	당해 연	도 12월			도 6월	31일까지			30일까지	
		일까지	지																											
하 반 기	12월 1	지난 연	다음 연도																											
	일 부 터	도 7월 1	1월 1일부																											
	12월 14	일 부 터	터 다음 연																											
	일까지	당해 연	도 12월																											
		도 6월	31일까지																											
		30일까지																												

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					<u>전문의를 반드시 포함하여 구성해야함.</u> <u>가) 순환기내과 분과전문의 2인 이상. 이 경우 순환기내과 분과전문의에는 한국심초음과학회에서 인정하는 심초음파 인증의 1인이 포함되어야 함.</u> <u>나) 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상 (단, 전문의 자격 취득 후 10년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 경우에는 1인 이상)</u> <u>2) 심장통합진료팀은 마. 1)의 전문의 이외에 미취통증의학과 전문의, 영상의학과 전문의 등 필요한 인력을 포함하여 구성할 수 있음.</u> <u>3) 심장통합진료팀은 심장통합진료에 대면으로 참여하되, 부득이한 경우에는 화상으로 참여할 수 있음. 다만, 마. 2)의 전</u>	

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					<u>문의는 별도의 협진으로 대면 및 화상 참여를 대신할 수 있음.</u> <u>4) 심장통합진료팀 전원이 동 시술의 시행에 동의한 경우 동 시술을 시행할 수 있음.</u> <u>5) 심장통합진료팀은 심장통합진료팀 전원이 동 시술의 시행에 동의하지 않은 경우 재논의를 거쳐 합의된 치료방침을 결정해야함. 이 경우 재논의에는 환자 담당 전문의(주치의)와 시술 담당 전문의가 반드시 참여해야 함.</u> <u>6) 순환기내과 전문의와 심장혈관흉부외과 전문의는 마. 1)의 심장통합진료 이전 또는 마. 5)의 재논의 이전에 환자 또는 보호자에게 각 치료법의 위험과 편익을 충분히 설명하</u>	

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					<u>여야 하며, 재논의에 참여한 환자 담당 전문의는 의료진의 최종 결정사항을 환자 또는 보호자에게 충분히 설명하여야 함.</u> <u>7) 경흉부 초음파, 경식도 초음파, 심장 관련 CT 촬영 결과 등 필수적인 검사결과를 구비한 후에 심장통합진료를 실시하여야 하며, 별지 제42호 서식의 클립을 사용한 경피적 경도관 승모판 재건술 심장통합진료 기록지에 심장통합진료 시간 및 장소, 참여 전문의 성명 및 서명, 치료방침 및 결정사유 등을 기재하여 요양급여비용 청구 시 서식을 첨부하여야 함.</u> <u>바. 기타</u> <u>1) 실시기관은 치료효과성 등의</u>	

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
					판단을 위해 시술 결정 사유, 시술 전후 환자 상태, 합병증 발생 유무 등에 대한 임상 자료를 별지 제3호 서식의 「시술 전·중·후」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모관 재건술 임상자료 관리 항목 및 제4호 서식의 「추적 관찰」 클립을 사용한 경피적 경도관 승모관 재건술 임상자료 관리 항목을 통해 관리하여야 함. 2) 치료효과성 등 급여 적정성에 대한 재평가에 필요한 세부사항은 별도로 정함.	
IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로 신청된 항목중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목			IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로 신청된 항목중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목			
제2장 검사료			제2장 검사료			
나723 경피적	6분 건기검사	나723 경피적 혈액산소포화도측정 [1일당]의 소정점수를 산정함	<삭제>	<삭제>	<삭제>	(제개정 사유) 행위 재분류

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
<u>혈액산소</u> <u>포화도측정</u>	<u>6 minutes</u> <u>walk test</u> <u>(호흡곤란을</u> <u>호소하는</u> <u>환자와</u> <u>검사자가</u> <u>함께</u> <u>걸으면서</u> <u>6분간 걷는</u> <u>거리와</u> <u>걸을 때의</u> <u>산소포화도</u> <u>를 측정한</u> <u>경우)</u>					관련 기결정 고시 삭제